

28 - La Tuberculose Génitale chez la femme - Pr. HAROU

Ce cours est un cours destiné aux étudiants de 5ème année de médecine. On va aborder dans ce cours la tuberculose d'une tâche de la part. En guise d'introduction, il faut dire que la tuberculose constitue un véritable problème de santé publique.

Il s'agit d'un problème endémique dans plusieurs zones défavorisées. Il est dû aux bacilles de coque, aux mycobactériums tuberculosis, et certainement, cette pathologie pose des problèmes aux cliniciens, des problèmes d'orthodiagnostic, pronostic et thérapeutique. Sur le plan épidémiologique, l'incidence mondiale est en augmentation.

L'OMS la considère comme une urgence globale. En 2008, 5,7 millions de nouveaux cas, dont 785 000, sont des formes extra-tumulaires. La tuberculose urogénitale chez la femme constitue 0,5% des tuberculoses extra-tumuli.

Et la tuberculose génitale de la femme constitue la moitié des tuberculoses urogénitales. Sur le plan idiopathogénique, la tuberculose est due essentiellement aux mycobactériums tuberculosis, plus rarement aux mycobactériums bovis. Le mycobactérium tuberculosis aux bacilles de coque est un bacille acido-alcoololysiste.

Sur le plan transmission, la transmission est essentiellement respiratoire. La tuberculose urogénitale est une atteinte la plus souvent secondaire à des localisations pulmonaires, osseuses ou ganglionnaires. Et la décimation se fait par voie hématogène dans 90% des cas.

Il y a bien sûr une possibilité de transmission par quantité. Mais exceptionnellement, l'atteinte peut être primaire par voie sexuelle. Sur le plan anatomopathologique, la tuberculose touche essentiellement les trompes.

La trompe peut apparaître tout à fait normale dans le cadre d'une endosalpingite, ou présenter à ses surfaces des tubercules dans le cadre d'une exosalpingite. L'endomètre est atteint dans 50 à 60% des cas. Et on peut avoir d'autres atteintes, telles que les atteintes cervicales, vaginales ou vulgaires.

Plusieurs formes sont à distinguer sur le plan macroscopique. On distingue les formes granulaires, ulcérocaséuses, fibroadhésives ou les formes ascétiques. Sur le plan macroscopique, la lésion est typiquement un granulome, hypothéliosigonthocylla avec nécrose caséuse.

Sur cet diapositif, voici quelques schémas et photos représentant d'une part la forme fibroadhésive et d'autre part la forme granulaire. Les images suivantes représentent comment est organisé le granulome hypothéliosigonthocyllaire avec la nécrose caséuse. Le diagnostic clinique peut être évoqué devant des signes d'altération de l'état général, une fièvre persistante ou des sueurs nocturnes.

Sur le plan fonctionnel, les patientes en général rapportent des douleurs pelviennes à type de compression, qui sont peu intenses et en général chroniques. Certaines patientes vont consulter pour une infertilité, d'autres vont consulter pour du trouble du cycle, surtout dans le cas d'un ménorrhée primaire ou dans le cas d'hypoménorrhée, dysménorrhée ou ménométrorrhée. D'autres signes peuvent être rapportés par ces patientes, tels que l'hémétrorrhagie post-ménopausique, un ballonnement abdominal, des logorrhées en général rebelles aux thérapeutiques usuelles ou des métrorrhagies provoquées.

L'examen clinique se trouvera en fonction de la localisation de la tuberculose, soit une hypertrophie des lèvres dans le cadre d'une tuberculose vulvaire, une ulcération génitale ou une fistule génitale, une masse cervicale dans le cadre d'une tuberculose cervicale, ou de l'acide et une masse latérale utérine fixée en cas de tuberculose anexielle. Sur le plan paraclinique, l'échographie abdominopelvienne reste l'examen de première intention. Elle va montrer le plus souvent une masse solide acoustique, de l'acide et parfois une hypertrophie endométriale.

L'hystérographie ou l'hystérosalpingographie est un examen très important, surtout en cas d'infertilité. Certains signes peuvent être constatés et qui évoquent fortement une tuberculose tubopéritoneale. Les trempes sont en général de contours irréguliers.

Il existe des images d'addition qui témoignent d'une ulcération caséuse, pour voir des images en faveur de fistules, des obstructions en tuber avec un hydrosalpinx ou un phimosis, et en général un aspect en chapelet qui témoigne de multiples sténoses. Au niveau utérin, on peut retrouver des images lacunaires témoignant de sénéchies, des déformations utérines à type d'hypoplasie, et des calcifications. L'hystéroscopie est un examen clé en matière de tuberculose.

Il a un triple intérêt. Diagnostic en faisant des biopsies, pronostiques et parfois thérapeutiques. L'hystéroscopie viendra compléter la celloscopie en montrant l'aspect de la cavité utérine, rechercher d'éventuelles sénéchies et permettre des biopsies endométriales.

La certitude diagnostique reste histologique, qui va montrer un granulon épithélioïde du canto cellulaire avec nécrose caséuse. D'autres examens peuvent être demandés en fonction du contexte clinique, un scanner, une imagerie par résonance magnétique, une radio de poumons, une intra-adhérent réaction, des prélèvements bactériologiques avec un examen direct et culture sur le milieu de Weinstein, et bien sûr, ne pas oublier le bilan masculin dans le cadre de l'infertilité, notamment le spermogramme. Différentes formes cliniques peuvent être distinguées selon l'évolution, selon l'âge, selon la localisation.

Sur le plan de l'évolution, il y a des formes latentes, des formes dites aiguës et d'autres chroniques, et puis des formes pseudotumorales. La tuberculose peut toucher la jeune fille prépubère, comme elle peut toucher la femme l'opposé. La localisation peut être diverse, au niveau vaginal, cervical, vulvaire, et bien sûr, anexiale.

Sur le plan thérapeutique, le traitement a pour but d'éradiquer le germe responsable, éviter les séquelles de tuberculose, et améliorer la fertilité. Le traitement est essentiellement médical. Il est basé sur l'association d'antituberculeux pendant au moins six mois.

Le protocole utilisé au Maroc est deux mois d'attaque associant rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et éthambutol, et puis quatre mois d'entretien associant rifampicine et isoniazide. Le tableau ci-dessous rapporte les différentes posologies. Dans certains cas, le traitement peut être chirurgical.

Grâce à la scélescopie, on peut faire des adhésiolyses, des drainages, d'abcès, une exérèse et une intervention de placétuber. Les scélescopies permettent essentiellement de traiter les signes chéutérines. La procréation médicalement assistée est réservée pour certains cas d'infertilité tuber.

En ce qui concerne les indications, quelle sera la forme de la tuberculose au traitement médical et de mise ? Dans le cas d'abcès tubo-ovarien, on peut associer un traitement chirurgical scélescopique. Dans le cas de pelvis adhérentiel, le traitement chirurgical scélescopique a visé d'adhésiolyse. Et en cas d'infertilité, la procréation médicalement assistée va être proposée si le pelvis est très adhérentiel après traitement médical avec une impossibilité de réparation tuber.

Les signes chéutérines peuvent être traités par scélescopie. En conclusion, on peut dire que la tuberculose reste une pathologie peu fréquente. Il faut penser à cette pathologie en cas d'améliorée primaire ou d'infertilité.

La scélescopie reste un examen très important qui va à la fois faire le diagnostic grâce aux aspects macroscopiques et pouvoir réaliser des groupes psy pour le diagnostic de certitude qui reste histologique. Le traitement est médical associé au nom de la chirurgie en cas de séquelles. Et puis, la PMA est réservée à des situations bien particulières.

Je vous remercie.